

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT - NGA

**QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ
(Kê đơn)**

Số: 05/.QTKB/TĐYTVN

Ngày ban hành: 10./10/2025

Lần ban hành: 01

Trách nhiệm	Biên soạn thảo	Người phê duyệt
Chức vụ Họ tên	Trần Thị Thảo Nguyên	Phó tổng giám đốc BS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Ký tên		

Lưu hành nội bộ



**QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
NGOẠI TRÚ
(Kê đơn)**

Mã số: 0.5.....
QTKB/TĐYTVN
Ngày ban hành:
10/10/2025
Lần ban hành: 01

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của tài liệu hướng dẫn quy trình này
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn
3. Mỗi cơ sở được phát 01 bản (có đóng dấu của người phê duyệt). Các cơ sở khi có nhu cầu thêm, đề nghị liên hệ với phòng KHTH – QLCL (Hà Nội) để có bản đóng dấu của người phê duyệt.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

☒	Ban lãnh đạo tập đoàn		
☒	Giám đốc các bệnh viện		

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (Tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

I. MỤC ĐÍCH

- Chuẩn hóa, thống nhất trình tự và nội dung các bước khám bệnh, kê đơn thuốc nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, tuân thủ pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo cơ sở tích hợp phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS/EMR).

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các trường hợp người bệnh khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh của Tập đoàn Y tế Việt – Nga.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện;

- Quy chế bệnh viện 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997;

- Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa;

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 về quy trình giám định BHYT

- Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 4750/ QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của bộ trưởng bộ y tế sửa đổi, bổ sung quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

BN : Bệnh nhân

KHTH : Kế hoạch tổng hợp

NB : Người bệnh

QLCL : Quản lý chất lượng

BS : Bác sĩ

BV : Bệnh viện

ĐD : Điều dưỡng

QĐ : Quyết định

KTV : Kỹ thuật viên

BYT : Bộ Y tế

TKX : Tật khúc xạ

CSKH : Chăm sóc khách hàng

CLS : Cận lâm sàng

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Các bước tiếp nhận và quản lý người bệnh khám mắt tại bệnh viện

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Bước 1: Đăng ký thông tin	Người bệnh /người nhà NB		Tại kiosk thông tin: - Tiếp nhận thông tin bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VNeID/ CCCD hoặc có thể nhập trực tiếp thông tin người bệnh tại kiosk 1. Lựa chọn hình thức khám: - BHYT - Dịch vụ 2. Nhận STT <i>Đối với BN đã thực hiện đăng ký online qua app/ web bỏ qua bước này</i>	Cơ sở HCM có thêm hình thức khám theo yêu cầu (VIP)
Bước 2: Đăng ký khám bệnh	Lễ tân	Marketing /CSKH	- Tiếp nhận NB theo số TT - Khai thác sơ bộ lý do - Chọn gói khám - Chọn phòng khám / BS khám - In phiếu khám (<i>trong phiếu có hướng dẫn đến phòng khúc xạ/phòng chức năng + phòng khám và thứ tự cần thực hiện trước sau</i>) Đối với BN đăng ký online đã được Marketing tư vấn và tích gói khám -> lễ tân chỉ thực hiện in phiếu khám	CS HCM: Phát sinh STT theo đầu mã gói khám TQ – chuyên sâu – tái khám
Bước 3: Thu phí	Thu ngân	Lễ tân	Thu phí - NB đóng phí khám bệnh theo bảng giá quy định tại Bệnh viện - Đầy cổng check-in (đầy tự động) – đối với NB đăng ký khám BHYT <i>NB có thể đóng phí bằng QR code động -> đưa bill giao dịch thành công cho thu ngân -> thu ngân xác nhận đã thanh toán -> BP. lễ tân đưa hồ sơ khám cho NB</i>	- CS HCM: Thu chênh đối với toàn bộ NB đăng ký khám BHYT ở các bước có thu phí - CS HL, HP: Thu toàn bộ chi phí, kết thúc khám sẽ hoàn lại tiền cho bệnh nhân
Bước 4: Đo thị lực, khúc xạ và nhãn áp	KTV Khúc xạ/ điều dưỡng Phòng khúc xạ/ chức năng		NB cầm phiếu khám (<i>trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khúc xạ/phòng chức năng</i>), thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, đến lượt vào phòng, thực hiện đo 1. Đo khúc xạ tự động 2. Đo thị lực: - Không kính - Kính lỗ	* CS HN: -Thực hiện thêm chỉnh kính - Đo nhãn áp hơi (đối với NB $\geq$ 40 tuổi)

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
			- Kính cũ (nếu có) 3. Đo nhãn áp hơi (trừ trường hợp NB bị viêm nhiễm và trẻ em dưới 15 tuổi) 4. Nhập toàn bộ kết quả lên phần mềm và in kết quả Hướng dẫn NB đến phòng có ghi trên phiếu khám	
Bước 5 Khám	Bác sĩ chuyên khoa	Điều dưỡng phòng khám	NB cầm phiếu khám (<i>trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khám</i>), thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, đến lượt vào phòng Khi đến lượt, bệnh nhân sẽ được mời vào gặp bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ thực hiện khám chi tiết: - Hỏi bệnh - Khám sinh hiển vi - Soi đáy mắt - Chỉ định chỉnh kính (nếu có), điều dưỡng/KTV nhập số liệu cấp đơn kính - Tư vấn, GDSK, ghi nhận thông tin về tình trạng người bệnh trên phần mềm về tình trạng bệnh, chẩn đoán, kê đơn thuốc, chỉ định điều trị ĐD hỗ trợ BS giải đáp những thắc mắc liên quan đến KCB, hướng dẫn sử dụng thuốc và chăm sóc mắt... cho NB trong phạm vi chuyên môn cho phép	CS HCM: Chỉnh kính (BS Nga tự chỉnh kính) – nếu có, BS Nga tự nhập KQ vào phần mềm trên form riêng của BS
Bước 6 Chỉ định CLS	Bác sĩ tại phòng khám	Điều dưỡng/KTV khoa khám bệnh	- NB được chỉ định thực hiện CLS: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng,... để trợ giúp chẩn đoán xác định: + In phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> NB nộp phí -> checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT-> chờ đến lượt -> thực hiện chỉ định CLS -> điều dưỡng/KTV Đẩy hình ảnh lên Forum hoặc Pacs => NB quay trở lại phòng khám ban đầu (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng)	Gói chỉ định CLS theo gói khám

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Bước 7 Đọc kết quả CLS	Bác sĩ/ phiên dịch tại phòng khám	Điều dưỡng phòng khám	- NB chờ đến lượt vào phòng khám theo sự điều phối của điều dưỡng - BS người Việt sẽ đọc và trả kết quả trên forum và Pacs, ký số trả kết quả - BS người Nga đọc và trả kết quả trên form và pacs, phiên dịch hỗ trợ dịch trên phiếu trả kết quả. BS và phiên dịch cùng ký trên phiếu trả kết quả CDHA. Phiên dịch ký trước bằng chữ ký điện tử, BS ký sau và ký số.	
Bước 8 Hướng xử trí	Bác sĩ chuyên khoa	Điều dưỡng phòng khám	1. Kê đơn: BS đưa ra chẩn đoán xác định và kê đơn thuốc và lịch hẹn tái khám (nếu cần) => cho NB ra về => Kết thúc khám 2. Các xử trí khác: - Chỉ định thêm CLS: Thực hiện tương tự như bước 6 - Chỉ định thủ thuật (tiểu phẫu): + In phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> NB nộp phí KHÔNG THU PHÍ: chỉ định chỉnh kính/những cận lâm sàng thực hiện lặp lại theo yêu cầu của bác sĩ : in phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> thu phí (giảm trừ 100%) -> checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT -> chờ đến lượt (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng)-> thực hiện-> phòng khám ban đầu (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng)	
Bước 9 Thực hiện thủ thuật (nếu có)	Điều dưỡng		1. NB Checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT -> chờ đến lượt 2. Mời người bệnh vào thực hiện theo STT 3. ĐD. Giải thích hướng dẫn người bệnh phối hợp - Thực hiện theo chỉ định - Trả kết quả trên PM - Hướng dẫn BN quay trở lại phòng khám để phòng khám kết thúc khám	

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Bước 10 Đóng phí đơn thuốc, Nhận thuốc	Thu ngân Kế toán BHYT	Khoa Dược/ Nhà thuốc	1. Đối với NB không sử dụng BHYT - Được duyệt đơn thuốc, đến nhà thuốc bệnh viện xác nhận thuốc cần mua - Thanh toán chi phí các loại thuốc được bác sĩ kê trong đơn thuốc (L1) - Nhận thuốc tại nhà thuốc (Dược sĩ sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuốc chi tiết, liều lượng, thời gian sử dụng, cách dùng, lưu ý khi dùng thuốc, tác dụng phụ, tương tác thuốc, và các điều kiện đặc biệt cần tránh khi dùng thuốc.) 2. Đối với NB có sử dụng BHYT: - Được duyệt đơn thuốc, NB ký bảng kê chi phí tại khu vực kế toán BHYT (L3), KT BHYT giữ bảng kê chi phí (1 bảng) - Thu ngân thu chênh chi phí (nếu có) - Lãnh thuốc BHYT tại nhà thuốc bệnh viện. Được giữ 1 đơn thuốc (có đóng dấu đã thanh toán BHYT)	Cơ sở HL, HP: Hoàn lại tiền BHYT thanh toán cho người bệnh
Bước 11 Kết thúc khám			KẾT THÚC QUY TRÌNH – LƯU HỒ SƠ	

Lưu ý:

1. Phát sinh mã QR động, NB có thể nộp phí ở bất kỳ đâu không cần đến quầy thu ngân
2. Khi xác nhận đã thu phí, tên NB mới thể hiện tại phòng có chỉ định để thực hiện trả kết quả